

היפרקלמיה

- באי ספיקת כליות בעקבות כשל בסינון הכלייתי כמות האשלגן בדם עולה.
- מזונות, תרופות, אי-שמירה על הנחיות ותקלות בדיאליזה מעלות את הסיכוי להיפרקלמיה
- מטופל נמצא בסכנת היפרקלמיה הגבוהה ביותר לפני ומיד לאחר הדיאליזה

מזונות המכילים אשלגן ברמה גבוהה:

- בננה, עגבנייה, אבוקדו, עשבי תיבול ירוקים (שמיר, אורגנו..), קקאו, פירות יבשים, אגוזים וגרעינים, דגים, קטניות

טיפול בהיפרקלמיה

- **קלציום** - הורדת הסיכון להפרעות קצב
- מעלה את פוטנציאל המנוחה של הלב, לא מטפל בהיפרקלמיה
- **וונטולין** באינהלציה
- הכנסת אשלגן לתאים בשרירי השלד והוצאתו מזרם הדם כחלק מפעילות רצפטורים β אגוניסטים
- **פוסיד 1 מ"ג/ק"ג**
- עידוד פינוי אשלגן
- **ביקרבונט**
- מאיץ הכנסת אשלגן לתאים וסותר חמצת
- **גלוקוז**
- עידוד הפרשת אינסולין אשר מכניס אשלגן לתאים
- בבית החולים - אינסולין וגלוקוז

כלל הטיפולים המוצעים כאן נגזרים מפרוטוקול פגיעות מעיכה ובכל מקרה דורשים אישור מהמוקד הרפואי



נכגע עם חשד לתסמונת מעיכה

שמור על בטיחות המטופל והצוות 1

פעל לפי עקרונות פרוטוקול גישה כללית למטופל 2

◀ השג גישה תוך־ורידית או תוך־לשדית
◀ תן עירוי נוזלים 3

בצע אק"ג ונטר את המטופל

תן טיפול נגד כאב לפי הוראות פרוטוקול
הטיפול בכאב

האם הצפי לזמן החילוץ או
לפינוי ארוך משעתיים?

לא

כן



◀ צמצם את מתן הנוזלים
◀ שקול מתן טיפול תרופתי –
גלוקוז, סודיום ביקרבונט, פוסיד,
קלציום גלוקונט או ונטולין

◀ המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי דחוף
לבית החולים הקרוב
◀ שקול העברת דיווח מקדים למוקד
או לבית החולים הקולט
◀ בצע הערכת מדדים חוזרת בכל
5-10 דקות

1 בטיחות ומניעה

- + הקפד על בטיחות הנפגע והצוות לאורך כל זמן החילוץ.
- + הסר מהנפגע טבעות וצמידים מוקדם ככל האפשר.
- + הימנע ממתן נוזלים, תרופות, או מזון P.O.

2 אנמנזה ובדיקה גופנית

- + שים לב אם היה לחץ ממושך (מעל 40 דקות) על פלג גוף תחתון (ישבן, גפיים תחתונות), על הגו או על גפה עליונה רחבת היקף.
- + האם יש ממצאים מעוררי חשד להתפתחותה של "תסמונת מדור" (כגון נפיחות, כאב, נימול).
- + שים לב אם השתן כהה.
- + יש לבצע אק"ג ולנטר את המטופל מוקדם ככל הניתן.

טיפול

- + יש לשאוף למתן עירוי נוזלים טרם שחרור האיבר הלכוד או טרם חילוץ המטופל.

3 מתן עירוי נוזלים

- + יש להשתמש בתמיסת סליין בלבד (או בשילוב עם גלוקוז) ולהימנע משימוש בתמיסת הרטמן.
- + מינון בשעתיים הראשונות לאירוע –
– למבוגר – 1 L/hr
– לילד – 20 ml/kg/hr
- + מינון לאחר שעתיים –
– למבוגר – 0.5 L/hr
– לילד – 10 ml/kg/hr

תוכן עניינים > כללי : פרק 5



סיבוכים בהתפתחות תסמונת מעיכה

- + היפוקלמיה – בעיקר בשל הצטברות נוזלים ב־Third space.
- + היפרקלמיה – בשל נזק לרקמות (בעיקר לשרירים). רמת היתר של אשלגן עלולה לגרום להפרעות קצב.
- + תסמונת מדור – עלולה להוביל לנמק של גפה.
- + אי־ספיקת כליות – תת־נפח הדם עלול להחמיר את הפגיעה במאזן הנוזלים והאלקטרוליטים.

אבחון

- + היפרקלמיה – נבחין בגלי T מחודדים, בהארכת מקטע PR, בצניחות ST ובהרחבת QRS.
- + תסמונת מדור – נזהה היעדר דופק, ירידה בתחושה, פְּרִסְתִּיזָה, חיוורון, כאב.

טיפול (בהתייעצות עם המוקד הרפואי)

+ גלוקוז

- ניתן למהול 25 gr גלוקוז ב־500 ml סליין כדי להשיג תמיסה של 5%.

+ סודיום ביקרבונט

- יינתן רק למטופלים עם עדות לפגיעה כלייתית (מיוגלובינוריה) או עם סימנים להיפרקלמיה, שניתן לנטרם ברציפות.
- מינון חד־פעמי – להוסיף 50 meq סודיום ביקרבונט ל־1000 ml סליין (או 2 מנות של 25 meq סודיום ביקרבונט ב־500 ml סליין).

+ פוסיד

- יינתן רק למטופלים עם עדות לגודש ריאתי בעקבות מתן עירוי נוזלים או עם סימנים להיפרקלמיה.
- מינון חד־פעמי – 1 mg/kg במתן תוך־ורידי.

+ ונטולין

- יינתן למטופלים עם סימנים להיפרקלמיה או עם עדות לברונכוספָּזם.
- מינון – 5 mg ונטולין עם 2 ml סליין באינהלציה.

+ קלציום גלוקונט

- יינתן למטופלים עם סימנים ברורים להיפרקלמיה באק"ג.
- מינון למבוגרים – אמפולה אחת (1 gr = 10 ml) של קלציום גלוקונט 10%, במתן תוך־ורידי איטי (1–2 דקות).
- + מינון לילדים – 60 mg/kg (עד למקסימום של 1 gr).